

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Arthrogram

معلومات الإقرار – نسخة المريض تصوير المفصل

1. What is an Arthrogram?

An Arthrogram is a procedure that injects contrast media into a joint. The contrast injection is done with guidance from imaging machines such as ultrasound, or x-ray.

After the injection of contrast, further pictures are then taken with CT, MRI or x-ray.

If you require more information on the imaging methods used for an arthrogram and the risks involved in their use, please request more information.

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure may require the injection of a local anaesthetic. It is used to prevent or relieve pain, but will not put you to sleep.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant.
- If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.
- List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit please inform your doctor. (These activities are against Shariah Law)

4. During the procedure

Images of the joint will be taken.

The Radiologist (x-ray doctor) may inject local anaesthetic.

Using imaging as a guide the needle will be inserted into your joint. You must remain as still as possible.

When the needle is in the correct place the contrast will be injected. The needle is taken out and a dressing will be applied to the puncture site.

5. After the procedure

Staff will discuss with you what level of activity is suitable after your procedure.

1. ما هو تصوير المفصل ؟

تصوير المفصل هو إجراء يتم فيه حقن مادة وسط متباين داخل المفصل. يتم حقن المادة بتوجيه من قبل جهاز تصوير كجهاز الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية.

بعد حقن مادة الوسط المتباين ، يتم أخذ صور أخرى بواسطة التصوير المقطعي ، التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية.

للمزيد من المعلومات عن وسائل التصوير المستخدمة في تصوير المفصل والمخاطر المتعلقة بها ، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بوسيلة التصوير التي ستخضع لها – الموجات فوق الصوتية و ١ أو الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

ورقة المعلومات هذه يجب قراءتها مع ورقة المعلومات المتعلقة بالإجراء الذي ستخضع له (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟ يتطلب الإجراء حقنة مخدر موضعي . غرض الحقنة هو منع الشعور بالألم أو علاجه ، ولكنها لن تتسبب في نومك .

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً ، أو إن كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.
- إن كنت تتناول أيًا من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير المخدرة (المخالفة للشريعة الإسلامية) التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

4. أثناء الإجراء

تؤخذ صور للمفصل.

قد يقوم طبيب الأشعة بحقن المخدر الموضعي .

باستخدام التصوير كأداة للتوجيه ، يتم إدخال إبرة في المفصل . حاول أن لا تتحرك وأن تحافظ على سكونك قدر الإمكان.

عند وجود الإبرة في مكانها الصحيح ، يتم حقن مادة الوسط المتباين.

تتم إزالة الإبرة ويوضع الضماد على الموضع الذي تم إدخالها منه.

5. بعد الانتهاء من الإجراء

سيناقش معك الموظفين الذين أجروا الفحص لك مقدار الأنشطة التي يمكنك ممارستها بعد الإجراء .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Inflammation of the joint, resulting in an increase of fluid in and around the joint.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays (for CT and x-ray only).
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

7. What are the safety issues when you leave the hospital?

Take care not to bump the area that has been numbed with the local anaesthetic.

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

- pain, unrelieved by simple pain killers
- continuous bleeding or swelling at the puncture site
- redness or inflammation at the puncture site reduced mobility in the joint
- fever
- other warning signs the doctor may have asked you to be aware of.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر العصب . غالباً ما يكون مؤقتاً و من المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعصلات. يتطلب معالجات أخرى.
- التهاب المفصل مما ينتج عنه تراكم السوائل داخل و حول المفصل.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة معدل خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

احذر من أن تصاب المنطقة التي تم تخديرها بالمخدر الموضعي بأي إصابة أو ارتطام .

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو عانيت أياً مما يلي:

- ألم لا يتعافى باستخدام مضادات الألم المعتادة.
- نزيف مستمر أو تورم في منطقة إدخال الإبرة.
- احمرار أو التهاب في موضع إدخال الإبرة يقلل من مجال حركة المفصل.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ظهور أي علامات أخرى كان الطبيب قد نبّهك إليها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
